

시험 관영 코멘트



질분비물검사를 같이 하는 하이브리드 증례입니다. 이때 **질분비물검사 전 골반 내진검사**도 하는 것을 잊지 않도록 주의합니다.

질분비물과 질출혈을 주소로 온 환자에서는 전혀 다른 질병을 감별해야 되기 때문에 가장 먼저 **질분비물인지, 질출혈인지 파악하는 것이 중요합니다**. 산부/여성 파트의 CPX 항목은 특히 '여성력'에서 물어 볼 것이 많고 중요하기 때문에 이를 'Factor'에서 먼저 물어볼 수 있게 구성하였습니다.

질분비물 이상을 주소로 내원한 환자는 **분비물의 양상**에 대한 자세한 문진이 필요합니다. 분비물의 양은 **속옷 갈아입는 횟수나 패드 개수**로 물어 볼 수 있고, **색과 냄새, 거품이나 피취임 여부, 파가움이나 통증**이 동반되는지 여부를 확인해야 합니다. 분비물의 양상으로 추정 진단을 잡을 수 있습니다. 추가적으로 요로 감염을 감별하기 위한 배뇨 이상 여부를 함께 확인하고, 질염이 의심되는 환자라면 칸디다 질염이 호발하기 위한 **기저 질환(면역 약화 상황)**을 함께 확인해야 합니다.

질출혈의 원인은 기능성 자궁 출혈이 가장 흔한 원인이지만 다른 **기질적 원인**(임신 관련 문제, 내과 질환, 자궁 내 병변, 자궁경부암 등)을 배제한 후에 진단할 수 있습니다. 또 **출혈이 응급 상황인지** 먼저 파악하고 유산 가능성 등 병력을 고려하여 원인을 감별해야 하며, 필수 임상 술기로 **자궁 경부파파름검사 또는 질분비물검사를** 시행하게 될 수 있습니다. 부인과 질환은 산부인과 정기 검진에 대한 교육을 비롯하여 항상 교육해야 할 항목들이 유사합니다. 이런 항목들을 한 번 숙지해 두면 여러 케이스에 적용할 수 있습니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

질분비물

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
질분비물	골반염 (pelvic inflammatory disease)	[병력] 골반통, 자궁경부 움직임 때 통증, 발열, 배뇨통, 열, 복통, 오심, 구토 [검진] 하복부 압통, 반발통	[검사] 혈중 WBC, CRP, ESR, 질분비물 배양, 골반초음파 [치료] 안정, 수액, 진통제, 항생제 (Ceftriaxone+Doxycycline)

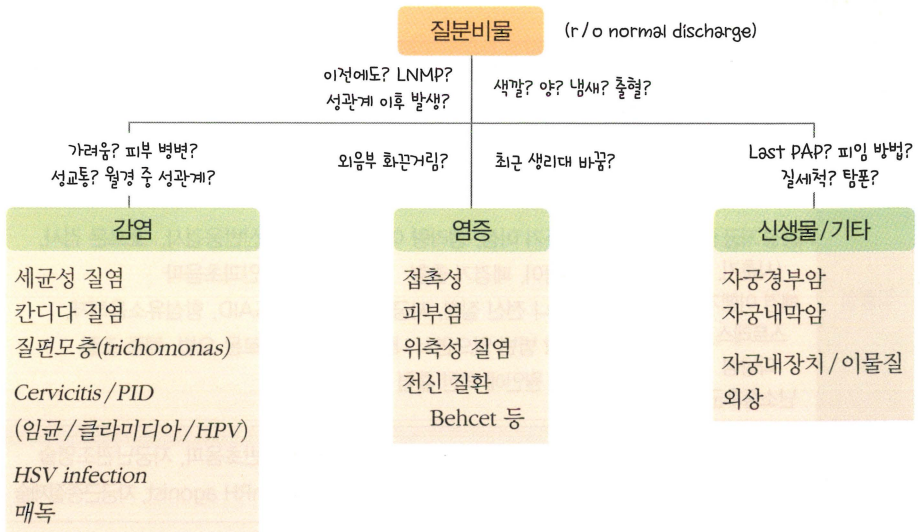
질분비물	자궁경부염 (cervicitis)	[병력] 노란색, 초록색 화농성 질분비물 [검진] 질경부 통증, 경부의 염증	[검사] 질분비물 gram staining [치료] 성교 파트너도 같은 약제로 치료, Ceftriaxone + Doxycycline
	세균질증 ★ (bacterial vaginosis)	[병력] 회색, 생선 비린내 나는 질분비물 [검진] 질벽에 유착된 회백색의 균질한 질분비물	[검사] 젖은경부도말검사, Whiff test, 배양 [치료] Metronidazole (파트너 치료 X)
	편모충질염 ★ (Trichomonas vaginitis)	[병력] 화농성, 코를 찌르는 듯한 냄새, 기포가 많음, 질가려움증 [검진] 딸기 모양의 질경부 (strawberry cervix)	[검사] 젖은경부도말검사, 배양 [치료] Metronidazole (파트너도 같이 치료)
	칸디다 질염 ★ (candida vaginitis)	[병력] 화끈거림, 치즈 형태의 질분비물, 심한 외음부 소양감, 배뇨통, 병력 상 당뇨병 [검진] 치즈 형태 질분비물, 소양감	[검사] 젖은경부도말검사, 배양 [치료] Clotrimazole, Miconazole, Fluconazole
	위축성 질염 ★ (atrophic vaginitis)	[병력] 얼굴 화끈거림, 식은땀, 폐경 이후, 성교통, 성교 후 출혈 [검진] 투명하고 수축된 질경부	[검사] 젖은경부도말검사 [치료] Topical estrogen cream

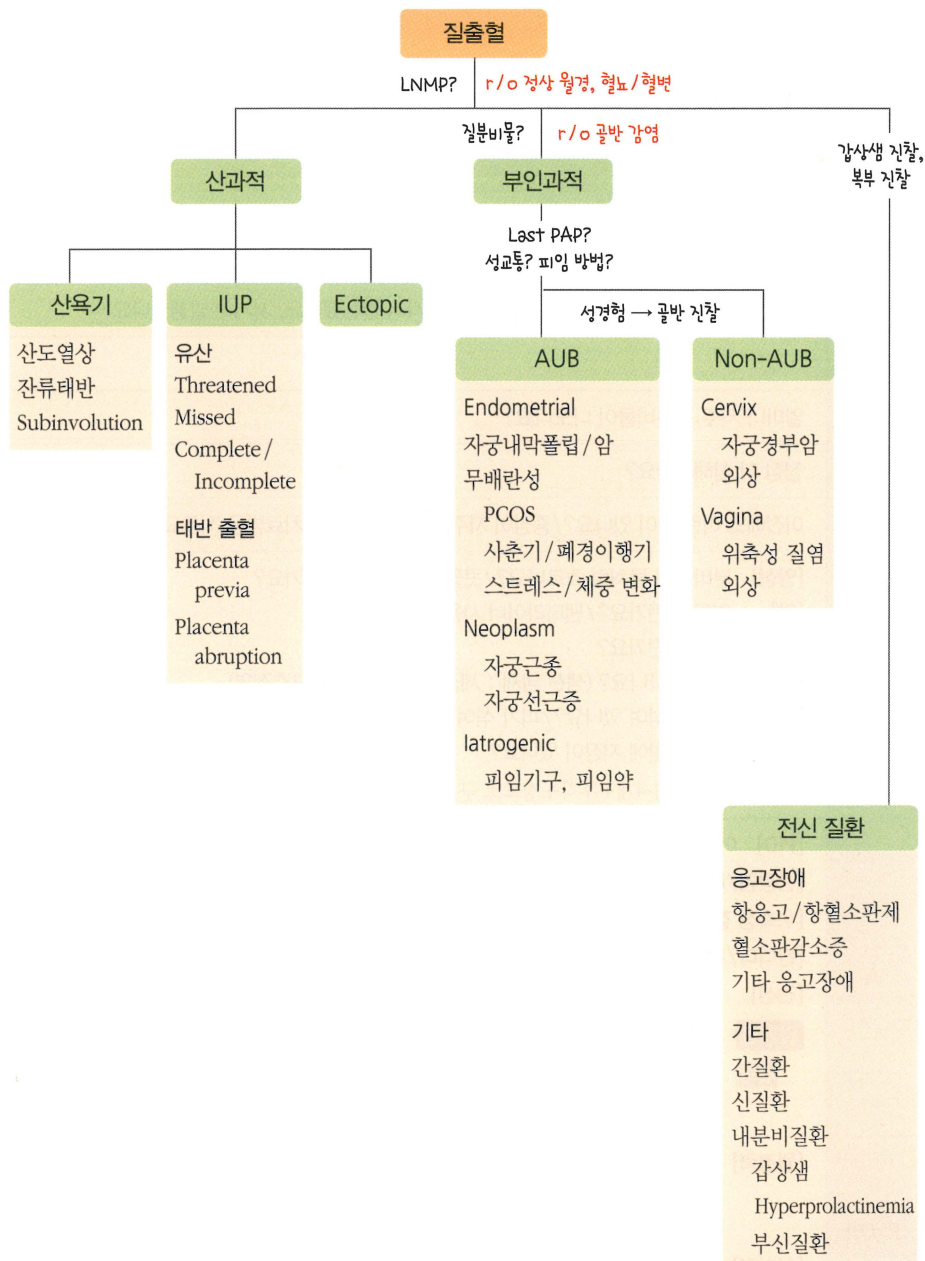
질출혈

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
질출혈	호르몬 제제, 경구피임약 사용	[병력] 호르몬 제제 처음 사용 시, 1~3개월 동안, 불규칙한 복용 시	[검사] 혈액검사 [치료] 호르몬 제제 규칙적 복용
	기능성 자궁 출혈 (사춘기, 폐경 이행기, 스트레스, 다낭성 난소증후군)	[병력] 생리 주기 이상, 생리량 이상, 생리 덩이, 폐경기 출혈 [검진] 임신이나 전신 질환, 자궁강 내 이상 병변 없으면서 내분 비학적 원인에 의한 출혈	[검사] 임신반응검사, 호르몬 검사, 부인과초음파 [치료] NSAID, 항섬유소용해제, 호르몬 요법, 체중 조절
	자궁근종 ★ (uterine myoma)	[병력] 30~45세, 월경 과다	[검사] 골반초음파, 자궁난관조영술 [치료] GnRH agonist, 자궁근종절제술

질출혈	자궁경부암★ (cervical cancer)	[병력] 성교 후 질출혈, 체중 감소	[검사] Pap smear, Biopsy, Cystoscopy, Proctoscopy 등 [치료] 수술, 항암 치료, 방사선 치료
	자궁내막암★ (endometrial cancer)	[병력] 폐경 후 질출혈, 폐경 전에는 월경 중 질출혈, 월경 과다	[검사] Endometrial aspiration biopsy, Cervical-Vaginal pap smear, 자궁난관조영술 등 [치료] 수술, 항암 치료, 방사선 치료
	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 월경 과다, 만성 피로, 추위불 내성, 변비, 체중 증가	[검사] 갑상샘 호르몬검사 [치료] Levothyroxine
	응고 질환	[병력] 멍들, 신체 출혈	[검사] 혈액응고검사 [치료] Vitamin K, 혈액응고인자 주사
	자궁 외 임신	[병력] 복통, 무월경, 질출혈, 임신 가능성 있는 경우	[검사] 소변 β -hCG, 질초음파, 복강경 [치료] Salpingectomy, Methotrexate
	유산 (절박유산, 계류유산)	[병력] 임신 중 질출혈 확인	[검사] 태아 초음파 [치료] Bed-rest, D&C, Methotrexate

증례별 알고리즘





기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

질분비물

☞ 먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

O	언제부터 질분비물 양이 많아지셨나요?/ 갑자기 발생했나요, 서서히 발생했나요?
L	-
D	얼마나 자주 질분비물이 나오나요?
Co	점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요?/증상이 자주 재발하나요? → 치료받은 적은요?
C	[양상] 분비물이 물처럼 흐르나요?/콧물처럼 끈적끈적한가요? [양] 양은 어떤가요?/팬티라이너 사용이 늘었나요? [색] 색은 어떤가요? [냄새] 냄새가 나나요? (생선 냄새 : 세균질증/악취 : 편모충질염) [추가] 거품이 섞여 있나요?/피가 섞여 있나요? [정도] 일상 생활에 지장이 있나요? 설명 시진 특징 4개+후각+정도로 구분해서 외울 수 있습니다.
A	[PID] 아랫배 통증/오심/구토 [방광염/비뇨염증] 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통이 있나요? [위축성 질염] 식은땀/안면홍조/야간 발한/질건조증이 있나요? [칸디다/위축] 외음부 가려움증/화끈함/따가움이 있나요? [전신] 발열/오한/체중 변화/피로감이 있나요? 암기법 골반(방)의(위) 외전 설명 질분비물 증례에서 필수적으로 시행해야 하는 wet smear를 위해 환자에게 <u>고관절을 외전</u>시키는 자세를 취하게 해야 합니다.
F = 여	[월경력] 월경은 규칙적으로 하시나요? or 폐경하셨나요? 월경 주기/월경량/월경통/LMP 임신 가능성/생리 주기와 질분비물 증가가 관련이 있나요? [산과력] 결혼하셨나요?/아이는 몇 명 있으신가요?(만-조-유-생) 자연분만 or 제왕절개?

	[성관계] 마지막 성관계가 언제인가요?/성교통이 있나요? 성관계 전 or 후 질분비물 증가가 심해지거나 피가 비치나요? (위축성, Candida, PID)/모든 분들께 여쭙보는 질문이니 당황하지 마시고 혹시 평소엔 성관계는 남편과만 하시나요? [피임] 피임하시나요? → 하고 있다면 어떤 방법으로 하고 있나요? (약 or 자궁 내 장치) [질세척] 질세척은 일주일에 몇 번 정도 하시나요?/질세정제로 하나요? 아니면 비누로 하나요? (질염, 질손상)
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 골반초음파 같은 산부인과 검진도 받으셨나요?
외	[외상] 복부나 외음부를 다치신 적 있나요? [수술] 예전에 부인과 시술 받으신 적 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압, 당뇨, 간염, 결핵) 이전에 골반 내 감염에 걸린 적 있나요?/방광염에 걸린 적이 있나요?
약	복용 중인 약물이 있으신가요?
사	술/담배, 직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스가 심하신가요?
가	남편분도 배뇨 시 불편한 증상을 호소하나요?/가족 중 암에 걸리신 분이 있나요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 신체 검진을 위해서는 불가피하게 골반 아래쪽 노출이 필요합니다. 오늘 측정할 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!) [앉아서] 1. 눈 : 결막 2. 입 : 구강 점막 3. CVAT [누워서] 4. 복부 진찰* : 시-청-타-촉 5. 사지 : 피부 긴장도
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 골반내진검사 후 질분비물검사 시행 Lithotomy 자세 → 소음순, 대음순 주위를 시진, 촉진 → 질 내부로 손가락을 넣어 덩이, cervical motion tenderness 확인 → 질경 삽입 → 자궁경부, 질벽 시진 → 검체 채취 → 면봉을 시험관에 담가 섞은 후 면봉 버리기 → 스포이드 이용하여 슬라이드 글라스 위에 1~2 방울 떨어뜨리기 → 커버글라스 덮기 → 질경 제거 후 마무리 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

질출혈

먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

O	언제부터 질출혈이 있었나요?/갑자기 발생했나요, 서서히 발생했나요?
L	어떤 상황에서 질출혈이 있었나요?
D	얼마나 자주 질출혈이 있었나요?
Co	점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요? → 치료받은 적은요?
C	[양] 양이 어느 정도 되나요? (팬티라이너 사용이 늘었나요?) [색] 색은 어떤가요? (일반적인 월경 시와 다른가요?) [양상] 핏덩어리가 있나요? [냄새] 냄새가 나나요? [정도] 일상 생활에 지장이 있나요?
A	[출혈 경향] 쉽게 멎음/잦은 코피가 있나요? [전신] 발열/오한/체중 변화/피로감이 있나요? [탈수] 어지럼증/두근거림/소변량 변화가 있나요? (*응급 상황으로 : 두어목 호소) [Mass Effect] 빈뇨(F)/절박뇨(U)/야간뇨(N)/배뇨통(D)/잔뇨감(R)/복부 덩어리 [감상생저하] 추위불내성/변비 암기법 ▶ 질 출혈은 전신 탈수를 유발해서 담배 M갑 피고싶게 한다.
F = 여	[월경력] 월경은 규칙적으로 하시나요? or 폐경하셨나요? 월경 주기/월경량/월경통/LMP/임신 가능성 생리 주기와 질출혈이 관련이 있나요? [산과력] 결혼하셨나요?/아이는 몇 명 있으신가요? (만-조-유-생) 자연분만 or 제왕절개? [성관계] 마지막 성관계는 언제인가요?/성교통이 있나요? 성관계 전 or 후 질출혈이 발생했나요? 모든 분들께 여쭙보는 질문이니 당황하지 마시고 혹시 평소에 성관계는 남편과만 하시나요? [피임] 피임하시나요? → 하고 있다면 어떤 방법으로 하고 있나요? (약 or 자궁 내 장치)
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 pap test 같은 산부인과 검진도 받으셨나요? [예방접종] 자궁경부암 예방접종 맞으셨나요?

외	[외상] 복부나 외음부를 다치신 적 있나요? [수술] 예전에 부인과 시술 받으신 적 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압, 당뇨, 간염, 결핵)
약	복용 중인 약물이 있으신가요?
사	술/담배/직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스가 심하신가요?
가	가족 중 암에 걸리신 분이 있나요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 신체 검진을 위해서는 불가피하게 골반 아래쪽 노출이 필요합니다. 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기) [앉아서] 1. 눈 : 결막 2. 입 : 구강 점막 3. 목 : 갑상샘 촉진 [누워서] 4. 복부 진찰* : 시 - 청 - 타 - 촉 5. 사지 : 피부 긴장도
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 골반내진검사 후 자궁경부파파바름검사 시행 Lithotomy 자세 → 소음순, 대음순 주위를 시진, 촉진 → 질 내부로 손가락을 넣어 덩이, cervical motion tenderness 확인 → 질경 삽입 → 자궁경부, 질벽 시진 → 검체 채취 (2개의 브러쉬를 이용하여 360° 돌리면서 채취 → 슬라이드에 바르고 알코올에 담가 고정 → 질경 제거 후 마무리 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

	질분비물	질출혈
공감	질분비물이 많이 나와 불편하고 걱정이 되셨겠습니다.	갑작스러운 질출혈이 있어 많이 불편하고 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ○○○한 소견이 관찰되어 세균질증이 가장 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ○○○한 소견이 관찰되어 자궁 경부암을 완전히 배제할 수 없습니다.

감별 진단	하지만 환자분께서 당뇨를 5년 동안 앓고 있으시고, 이전 방광염에 걸린 병력 때문에 면역력이 약한 분들에게서 나타나는 칸디다 질염 등 다른 종류의 감염이 원인일 수도 있습니다.	하지만 그 외에도 경구피임약을 복용하는 것만으로도 비정상적인 질출혈이 있을 수 있고, 자궁근종이나 갑상샘저하증에 의해서도 발생할 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 혈액검사를 시행하고, 아까 채취한 질분비물을 배양시켜 현미경으로 관찰하는 검사를 추가적으로 시행하겠습니다. 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해 혈액검사를 시행하고, 골반초음파를 한 뒤 필요에 따라 조직검사를 시행하겠습니다. 괜찮으신가요?
치료	검사 후에도 세균질증으로 진단이 되면 경구항생제를 처방해 드릴테니 일주일 정도 드시면 됩니다.	검사 후에도 자궁경부암으로 진단이 되면 그 크기에 따라 수술이 필요할 수 있고, 단순한 자궁근종의 경우 약물 치료로도 조절이 가능합니다.
예후	지금부터 치료를 잘 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.	지금부터 치료를 잘 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[질세척 횟수] 잦은 질세척은 질 내부의 환경 유지에 좋지 않으며, 세균질증의 원인이 될 수 있습니다. 횟수는 일주일에 2~3회 정도가 적당합니다. 또한 질세척 시에서는 비누를 사용하지 마시고, 질세정제를 사용하세요. [정기검진 권유] 별다른 이상이 없다고 하더라도 정기적인 산부인과 검진을 권고해 드립니다. [기저 질환 교정] 또한 환자분께서는 당뇨 조절도 중요하므로 당뇨약도 규칙적으로 챙겨드시고, 식사 조절과 운동을 함께 병행하는 것이 좋습니다. [편모충질염의 경우] 남편분/성관계 파트너분의 치료도 동시에 시행되어야 합니다. [생활 습관 교정] 성관계 전후로 소변을 보는 습관도 필요하며, 위생 관리를 잘해주세요.	[정기검진 권유] 별다른 이상이 없다고 하더라도 정기적인 산부인과 검진을 권고해 드립니다. [생활 습관 교정] 성관계 전후로 소변을 보는 습관도 필요하며, 위생 관리를 잘해주세요. [응급 교육] 출혈량이 갑자기 많아지거나 어지럽고 두근거리는 증상이 생기는 경우 바로 병원으로 내원해 주세요.
질문	궁금하신 것 있으신가요?	

❖ 기본적 진단 검사 계획

- ① 자궁경부염/자궁내막염/자궁경관염 : CBC, ESR, CRP, 질분비물 gram 염색 및 배양검사, 질식초음파검사
 Cervical motion tenderness 있으면 자궁경부염이고, 이것이 진행되면 자궁내막염 → 자궁경관염
 → 이들은 *N. gonorrhoeae*가 원인균이고, 질염은 외음부 증상이 더 강하며, 균의 종류가 다름
- ② 세균질증/편모충질염/칸디다 질염 : Whiff test, 질분비물 산도검사, KOH 도말현미경검사, wet smear

❖ 치료 계획

- ① 세균질증 : Oral metronidazole, 너무 잦은 성교나 질 깊숙이 물로 씻어내는 습관 등으로 발병, 재발 가능, 임신 중이어도 치료함
- ② 편모충질염 : Oral metronidazole (편모충질염은 파트너도 함께 치료)
- ③ 칸디다 질염 : Oral fluconazole이나 nystatine 바르기, 임신/당뇨/항생제 사용, 환자 호발 가능
- ④ 위축성 질염 : Estrogen cream 바르기 (1~2주)
- ⑤ PID : 입원 및 정맥 항생제

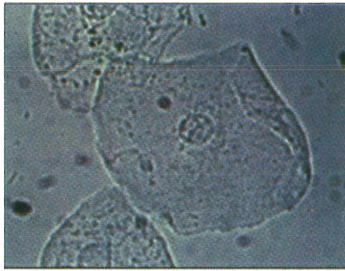
❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 잦은 질세척은 질 내부 환경 유지에 좋지 않으며, 감염이 생길 수 있음을 교육
- ② 위생적인 성생활, 피임 교육, 치료 성공에 대한 확신, 수치심 덜어주기
- ③ 증상 지속 시 추적 관찰 필요함을 설명
- ④ 자궁 내 장치는 감염의 원인이 될 수 있음을 설명

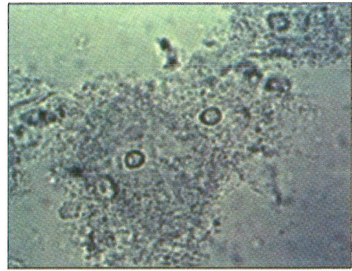
	세균성 질염	트리코모나스 질염	칸디다 질염	위축성 질염
원인	Gardnerella vaginalis	Trichomonas vaginalis	Candida species	폐경 후 호발 Estrogen 결핍
특징	회색 분비물 썩은 생선 냄새	노란색 분비물 Strawberry cervix	치즈 같은 분비물 냄새 없음	질점막 위축

wet smear	Clue cell	Trichomonas	Hyphae, Spores	정상
whiff test	+	-	-	-
pH	5~6	6~7	3~4	5~6
치료	Metronidazole 파트너의 치료는 불필요	Metronidazole 파트너 치료 필요	Antifungal drug 파트너의 치료는 불필요	에스트로겐 크림 or 질정

[위축성 질염]



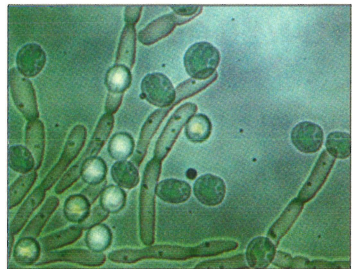
[세균성 질염]



[트리코모나스]



[칸디다]



질출혈

❖ 기본적 진단 검사 계획

- ① 자궁 외 임신/유산 : 소변 임신반응검사, 질경유 초음파
- ② 자궁근종 : 골반초음파, 자궁난관조영술
- ③ 자궁경부암 : Pap smear & biopsy
- ④ 자궁내막암 : Endometrial aspiration biopsy
- ⑤ 갑상샘저하증 : 갑상샘 호르몬 검사

❖ 치료 계획

- ① 자궁 외 임신/유산 : methotrexate, 복강경 수술, dilatation & curettage
- ② 자궁근종 : GnRH agonist, 자궁근종절제술
- ③ 자궁경부암 : 수술, 항암 치료, 방사선 치료
- ④ 자궁내막암 : 수술, 항암 치료, 방사선 치료
- ⑤ 갑상샘저하증 : levothyroxine

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 출혈 원인 감별 후 스트레스, 체중 조절, 복용 중인 약제 조절 등 그에 따른 생활 습관 조절
- ② 정기적인 산부인과 검진으로 여성암에 대한 검진을 꾸준히 하는 것이 필요함을 교육
- ③ 위생적인 성생활, 피임 교육



keyword

질분비물 : 양, 색, 냄새, 거품/피쉬임, 통증

질출혈 : 응급, 기질적 원인 배제

질분비물 교육 : 질세척은 2~3회/주, 정기 검진 권유, 편모충은 파트너도 치료

질출혈 교육 : 응급 상황 교육

공통 교육 : 정기적 산부인과 검진